

Nota Técnica: NTE.SES.RAS.002 - DAP/DTE/DGE - Versão 2.0

Assunto: Critérios e fluxo de encaminhamento para a especialidade de Ginecologia e Obstetrícia na Atenção Primária à Saúde (APS).

Considerando a necessidade de organizar os fluxos e garantir o acesso oportuno e qualificado à especialidade de Ginecologia e Obstetrícia na rede municipal de saúde;

O Núcleo de Gestão da Qualidade e Processos publica a **Nota Técnica: NTE.SES.RAS.002**, que estabelece os critérios e fluxos de encaminhamento para a especialidade de Ginecologia/Obstetrícia na Atenção Primária à Saúde (APS).

Esta nota tem como finalidade orientar os profissionais da APS na identificação de condições clínicas elegíveis e no direcionamento adequado dos casos para a especialidade de Ginecologia e Obstetrícia, otimizando o fluxo assistencial na rede municipal de saúde e promovendo a continuidade, a integralidade e a resolutividade do cuidado à saúde da mulher.

1. ORIENTAÇÕES GERAIS

A atuação dos profissionais da APS segue as atribuições previstas nas normativas do Ministério da Saúde, da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) e dos respectivos Conselhos Profissionais, bem como nos protocolos institucionais vigentes.

No município de Joinville, as rotinas também devem seguir os protocolos municipais e os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) instituídos. Todos os documentos norteadores estão disponíveis para acesso no site da prefeitura, em [Protocolos, POPs e outros documentos da Saúde - Prefeitura de Joinville](#), entre eles:

- Linha de Cuidado para Controle dos Cânceres do Colo do Útero e Mama;
- Protocolo de Enfermagem - Volume 3 - Cuidado em Saúde da Mulher - Versão 1.6;
- Protocolo de Pré-natal do Município de Joinville;
- Protocolo para a Inserção do Dispositivo Intrauterino (DIU);
- Protocolo de Acesso à Esterilização Cirúrgica Voluntária e Eletiva (Laqueadura / Vasectomia).

2. CRITÉRIOS PARA ENCAMINHAMENTO

Importante:

A ocorrência da menarca é critério mínimo para encaminhamento à especialidade de Ginecologia. Casos que demandem avaliação ginecológica anterior à menarca devem ser acompanhados primariamente pela Pediatria e ESF.

Todos os encaminhamentos para a Ginecologia e Obstetrícia na APS devem ser precedidos de avaliação clínica inicial realizada por médico ou enfermeiro da Estratégia Saúde da Família (ESF) e devem conter informações clínicas completas incluindo:

- Antecedentes familiares, obstétricos maternos e perinatais;
- Sintomatologia detalhada e tempo de evolução;
- Exame físico atualizado;
- Comorbidades diagnosticadas;

- Tratamentos farmacológicos (com descrição exata de dose e posologia) ou intervenções não-farmacológicas já em uso;
- Resultado de exames complementares (se solicitados e pertinentes);
- Outras informações relevantes para o caso.

Importante:

- Encaminhamentos com dados incompletos, sem justificativa clínica clara ou que não cumpram os critérios estabelecidos nesta nota técnica poderão ser devolvidos para complementação na unidade de origem.
- Quando o encaminhamento for realizada por enfermeiro da ESF, o direcionamento à especialidade só deve ocorrer mediante a realização e o registro prévio de todos os exames complementares obrigatórios. Na ausência destes, a paciente deve passar primeiro por avaliação médica na APS para solicitação e análise dos exames necessários.

Os encaminhamentos devem ser realizados pelo SIG-SaudeTech com o código específico:

- 99000775 - Consulta em Ginecologia UBS/Uni - Adulto (PMV).

O fluxograma do Anexo A, detalha o encaminhamento para a especialidade de ginecologia e obstetrícia na Atenção Primária à Saúde (APS).

2.1 PRÉ-NATAL DE MÉDIO RISCO

A gestante de Médio Risco deve ser acompanhada pela equipe de APS durante toda a assistência ao pré-natal com consultas médicas e de enfermagem e avaliação do especialista (ginecologista obstetra), quando necessário, conforme Instrumento de Estratificação de Risco Gestacional e orientações contidas no Protocolo de Pré-Natal, disponível para acesso no site da prefeitura, em [Protocolos, POPs e outros documentos da Saúde - Prefeitura de Joinville](#).

2.2 SANGRAMENTO UTERINO ANORMAL

CONDIÇÕES CLÍNICAS QUE INDICAM A NECESSIDADE DE ENCAMINHAMENTO	PROFISSIONAL SOLICITANTE
Sangramento uterino anormal na pré-menopausa <u>refratário ao tratamento clínico por 6 meses</u>	Médico(a) ESF
Sangramento uterino na pós-menopausa	Enfermeiro(a) ESF* Médico(a) ESF
Sangramento uterino anormal associado a fatores de risco para câncer de endométrio**	Enfermeiro(a) ESF* Médico(a) ESF
* Encaminhar somente quando já possuir os exames complementares obrigatórios realizados e com resultados disponíveis, registrando o resultado no encaminhamento. Na ausência dos exames obrigatórios, a paciente deve ser encaminhada para consulta médica na APS, a fim de avaliação e solicitação dos exames necessários. ** Fatores de risco para câncer de endométrio: idade ≥ 45 anos, obesidade, nuliparidade, diabetes, anovulação crônica, uso de tamoxifeno, tumor secretor de estrogênio, Síndrome de Lynch (câncer colorretal hereditário não poliposo), Síndrome de Cowden, história familiar de câncer de endométrio, ovário, mama ou cólon.	

Obrigatório conter no encaminhamento:

- Descrição da história clínica completa incluindo:
 - Características do sangramento (tempo de evolução, frequência dos episódios, volume de sangramento, presença de coágulos, número de absorventes utilizados)
 - História ginecológica e obstétrica,
 - Comorbidades,
 - Tratamentos farmacológicos (com dose e posologia) ou não-farmacológicos em uso e
- Descrição do exame físico ginecológico;
- Resultado do laudo com data de ultrassonografia transvaginal ou pélvica;
- Resultado com data dos exames:
 - Hemograma, se suspeita clínica de anemia;
 - TSH e T4 Livre, se suspeita clínica de hipotireoidismo;

- Prolactina, se suspeita de clínica hiperprolactinemia; Hemograma e coagulograma, se suspeita clínica de coagulopatia.
- Resultado com data de Teste Rápido de Gravidez (TRG) e/ou Beta-Gonadotrofina Coriônica Humana (B-HCG) nas mulheres em idade fértil.

Importante:

Situações que NÃO necessitam de encaminhamento e podem ser manejadas pelas equipes ESF:

- Sangramento de escape por uso de anticoncepcional hormonal de baixa dosagem;
- Sangramento uterino anormal na menacme sem tratamento clínico inicial na APS.

2.3 AMENORREIA

CONDIÇÕES CLÍNICAS QUE INDICAM A NECESSIDADE DE ENCAMINHAMENTO	PROFISSIONAL SOLICITANTE
<u>Amenorreia primária</u> : maiores de 14 anos sem caracteres sexuais secundários ou maiores de 16 anos com caracteres sexuais secundários	Enfermeiro(a) ESF* Médico(a) ESF
<u>Amenorreia secundária</u> descartadas gravidez, alterações de função tireoidiana e hiperprolactinemia	Médico(a) ESF
* Encaminhar somente quando já possuir os exames complementares obrigatórios realizados e com resultados disponíveis, registrando o resultado no encaminhamento. Na ausência dos exames obrigatórios, a paciente deve ser encaminhada para consulta médica na APS, a fim de avaliação e solicitação dos exames necessários.	

Obrigatório conter no encaminhamento:

- Descrição da história clínica completa incluindo sintomatologia, exame físico ginecológico, história ginecológica e obstétrica, comorbidades, tratamentos farmacológicos (com dose e posologia) ou não-farmacológicos em uso e outras informações relevantes;
- Descrição do laudo com data de ultrassonografia transvaginal ou pélvica;
- Amenorreia secundária - resultado com data de:
 - FSH;
 - TSH;

- Prolactina;
- B-HCG sérico.

2.4 DOR PÉLVICA CRÔNICA, ENDOMETRIOSE E ADENOMIOSE

CONDIÇÕES CLÍNICAS QUE INDICAM A NECESSIDADE DE ENCAMINHAMENTO	PROFISSIONAL SOLICITANTE
Dor pélvica de origem ginecológica, há mais de 6 meses, <u>refratária ao tratamento específico da condição</u>	Médico(a) ESF
Dor pélvica crônica sem etiologia definida <u>após investigação inicial na APS</u>	Médico(a) ESF
Dor pélvica associada a diagnóstico confirmado de endometriose e/ou adenomiose <u>refratária ao tratamento clínico inicial na APS</u>	Médico(a) ESF

Obrigatório conter no encaminhamento:

- Descrição da história clínica completa incluindo sintomatologia;
- Exame físico ginecológico;
- História ginecológica e obstétrica;
- Comorbidades;
- Tratamentos farmacológicos (com dose e posologia) ou não-farmacológicos em uso;
- Descrição da investigação e descarte de causas não-ginecológicas;
- Descrição do laudo com data de ultrassonografia transvaginal ou pélvica;
- Outras informações relevantes

Importante:

Situações que NÃO necessitam de encaminhamento para ginecologia e podem ser manejadas pelas equipes ESF:

- Dor pélvica crônica de origem não-ginecológica;
- Dismenorreia/cólica menstrual

2.5 MIOMATOSE UTERINA

CONDIÇÕES CLÍNICAS QUE INDICAM A NECESSIDADE DE ENCAMINHAMENTO	PROFISSIONAL SOLICITANTE
Mioma intramural ou subseroso e sangramento uterino anormal <u>refratário ao tratamento clínico otimizado por 3 meses</u>	Médico(a) ESF
Mioma intramural ou subseroso e sangramento uterino anormal em mulher que deseja gestar	Enfermeiro(a) ESF* Médico(a) ESF
Mioma submucoso e sangramento uterino anormal	Enfermeiro(a) ESF* Médico(a) ESF
Miomatose com sintomas compressivos (aumento da frequência urinária, esvaziamento vesical incompleto, constipação)	Enfermeiro(a) ESF* Médico(a) ESF
* Encaminhar somente quando já possuir os exames complementares obrigatórios realizados e com resultados disponíveis, registrando o resultado no encaminhamento. Na ausência dos exames obrigatórios, a paciente deve ser encaminhada para consulta médica na APS, a fim de avaliação e solicitação dos exames necessários.	

Obrigatório conter no encaminhamento:

- Descrição da história clínica completa incluindo:
 - Sintomatologia,
 - Exame físico ginecológico,
 - História ginecológica e obstétrica,
 - Comorbidades,
 - Tratamentos farmacológicos (com dose e posologia) ou não-farmacológicos em uso e outras informações relevantes;
- Descrição do laudo com data de ultrassonografia transvaginal;
- Descrição com data do hemograma, se suspeita clínica de anemia;
- Outras informações relevantes

Importante

Situações que NÃO necessitam de encaminhamento para ginecologia e podem ser manejadas pelas equipes ESF:

- Miomatose assintomática
- Mioma intramural ou subseroso sintomático sem tratamento clínico inicial na APS

2.6 CISTOS, TUMORES E MASSAS ANEXIAIS

CONDIÇÕES CLÍNICAS QUE INDICAM A NECESSIDADE DE ENCAMINHAMENTO	PROFISSIONAL SOLICITANTE
Massa anexial com O-RADS 2*, O-RADS 3 e O-RADS 4,	Enfermeiro(a) ESF Médico(a) ESF
Cisto hemorrágico típico em pacientes na pós-menopausa	Enfermeiro(a) ESF Médico(a) ESF
Teratoma/cisto dermoide típico < 10 cm	Enfermeiro(a) ESF Médico(a) ESF
Endometrioma típico < 10 cm	Enfermeiro(a) ESF Médico(a) ESF
Cisto de inclusão peritoneal típico de qualquer tamanho	Enfermeiro(a) ESF Médico(a) ESF
Hidrossalpinge típica de qualquer tamanho, e que outras causas de dor pélvica já foram excluídas	Enfermeiro(a) ESF Médico(a) ESF

Obrigatório conter no encaminhamento:

- Descrição da história clínica completa incluindo sintomatologia, exame físico ginecológico, história ginecológica e obstétrica, comorbidades, tratamentos farmacológicos (com dose e posologia) ou não-farmacológicos em uso e outras informações relevantes;
- Descrição de história familiar de câncer de mama ou de ovário (sim ou não);
- Descrição do laudo com data de exame de imagem (ultrassonografia, RNM).

2.7 MASTALGIA

CONDIÇÕES CLÍNICAS QUE INDICAM A NECESSIDADE DE ENCAMINHAMENTO	PROFISSIONAL SOLICITANTE
Mastalgia persistente com falha no manejo inicial	Médico(a) ESF

Obrigatório conter no encaminhamento:

- Descrição da história clínica completa incluindo
 - Sintomatologia,
 - Exame físico ginecológico,
 - História de trauma mamário,
 - História ginecológica e obstétrica,
 - Comorbidades,
 - Tratamentos farmacológicos (com dose e posologia) ou não-farmacológicos em uso
- Descrever se mastalgia cíclica ou não cíclica;
- Descrição de falha terapêutica no manejo inicial na APS;
- Descrição do laudo com data de ultrassonografia e/ou mamografia.
- Outras informações relevantes.

2.8 DESCARGA PAPILAR

CONDIÇÕES CLÍNICAS QUE INDICAM A NECESSIDADE DE ENCAMINHAMENTO	PROFISSIONAL SOLICITANTE
Descarga papilar quando descartada causas fisiológicas	Médico(a) ESF

Obrigatório conter no encaminhamento:

- Descrição da história clínica completa incluindo:
 - Sintomatologia,
 - Exame físico ginecológico,
 - História ginecológica e obstétrica,
 - Comorbidades,
 - Tratamentos farmacológicos (com dose e posologia) ou não-farmacológicos em uso;
 - Descrição do exame clínico das mamas;
 - Descrição da investigação de descarte de causas fisiológicas;
- Descrição do resultado de exames com data:
 - Prolactina;

- B-HCG sérico, se em fase reprodutiva.

2.9 HIPERTROFIA MAMÁRIA

CONDIÇÕES CLÍNICAS QUE INDICAM A NECESSIDADE DE ENCAMINHAMENTO	PROFISSIONAL SOLICITANTE
Mulheres com 18 anos ou mais e menarca há pelo menos 2 anos com mamas de grande aumento do volume e/ou assimetria	Enfermeiro(a) ESF* Médico(a) ESF
* Atenção: Pacientes sem os exames obrigatórios realizados não devem ser enviadas à especialidade; encaminhe-as para consulta médica na APS.	

Obrigatório conter no encaminhamento:

- Descrição da história clínica completa incluindo:
 - Sintomatologia,
 - Exame físico ginecológico,
 - História ginecológica e obstétrica,
 - Comorbidades,
 - Tratamentos farmacológicos (com dose e posologia) ou não-farmacológicos em uso;
- Descrição do desejo de ser submetida à cirurgia de mamoplastia redutora;
- Descrição do peso, altura e IMC (critério de exclusão, se IMC > 27);
- Descrição se tabagismo presente ou não (critério de exclusão, se tabagista);
- Resultado do laudo com data de:
 - Ultrassonografia, se < de 40 anos;
 - Ultrassonografia e mamografia, se ≥ 40 anos

2.10 CLIMATÉRIO

CONDIÇÕES CLÍNICAS QUE INDICAM A NECESSIDADE DE ENCAMINHAMENTO	PROFISSIONAL SOLICITANTE
Persistência de sintomas associados ao climatério quando: ● Falha no tratamento clínico por pelo menos 6 meses e; ● Intenção da paciente no tratamento com TRH e; ● Ausência de contraindicações absolutas à TRH.	Médico(a) ESF

Obrigatório conter no encaminhamento:

- Descrição da história clínica completa incluindo:
 - Sintomatologia,
 - Exame físico ginecológico,
 - História ginecológica e obstétrica,
 - Comorbidades,
 - Tratamentos farmacológicos (com dose e posologia) ou não-farmacológicos em uso;
- Descrição da falha do tratamento clínico por pelo menos 6 meses;
- Descrição do laudo com data da mamografia e/ou ultrassonografia de mamas;
- Descrição da intenção da paciente em TRH;
- Descrição da presença ou ausência de contraindicações absolutas e/ou relativas;
- Outras informações relevantes

Importante:

Situações que NÃO necessitam de encaminhamento e podem ser manejadas pelas equipes ESF:

- Climatério assintomático ou pouco sintomático;
- Climatério sem tratamento clínico prévio por pelo menos 6 meses;
- Climatério com contraindicação absoluta para TRH;
- Climatério sem intenção da paciente para TRH.

2.11 INCONTINÊNCIA URINÁRIA

CONDIÇÕES CLÍNICAS QUE INDICAM A NECESSIDADE DE ENCAMINHAMENTO	PROFISSIONAL SOLICITANTE
Incontinência sem resposta ao tratamento clínico por 6 meses	Médico(a) ESF
Incontinência urinária associada a prolapso genital	Enfermeiro(a) ESF Médico(a) ESF

Obrigatório conter no encaminhamento:

- Descrição da história clínica completa incluindo:
 - Sintomatologia,
 - Exame físico ginecológico,

- História ginecológica e obstétrica,
- Comorbidades,
- Tratamentos farmacológicos (com dose e posologia) ou não-farmacológicos em uso e
- Outras informações relevantes.

2.12 INFERTILIDADE

CONDIÇÕES CLÍNICAS QUE INDICAM A NECESSIDADE DE ENCAMINHAMENTO:	PROFISSIONAL SOLICITANTE:
Se < 35 anos, relato de 1 ano tendo relações sexuais periódicas e sem sucesso na gestação. Se com mais de 35 anos, encaminhar após 6 meses de tentativa sem sucesso. Sempre encaminhar o casal.	Médico(a) ESF Enfermeiro(a) ESF*
*Atenção: pacientes sem os exames obrigatórios realizados não devem ser enviadas à especialidade; encaminhe-as para consulta médica na APS.	

Obrigatório conter no encaminhamento:

- Descrição da história clínica completa incluindo:
 - Sintomatologia,
 - Exame físico ginecológico,
 - História ginecológica e obstétrica,
 - Comorbidades,
 - Tratamentos farmacológicos (com dose e posologia) ou não-farmacológicos em uso;
- Descrição do laudo com data de ultrassonografia transvaginal;
- Parceiro: descrição do laudo com data de espermograma (resultado normal);
- Outras informações relevantes

2.13 OUTROS MOTIVOS

CONDIÇÕES CLÍNICAS QUE INDICAM A NECESSIDADE DE ENCAMINHAMENTO	PROFISSIONAL SOLICITANTE
• Tumores da vulva • Líquen vulvo-vaginal • Discromias • Prurido vulvovaginal crônico • Prolapso genital sintomático • Menopausa precoce (antes dos 40 anos) • Pólipos endometriais¹ • Pólipos endocervicais • Hímen imperfurado • Hipertrofia de pequenos lábios • Cisto de Bartholin sintomático • Vaginismo • Malformações ginecológicas^{**} • Útero de crescimento rápido¹ • Abortamento de repetição • Síndrome dos Ovários Policísticos^{***} • Espessamento endometrial ≥ 5 mm na pós-menopausa¹ • Corrimento vaginal recorrente com pelo menos 2 tentativas de tratamento consecutivas • Lesões condilomatosas anogenitais múltiplas ou de grande volume • Remoção de DIU com fio não visualizado²	Médico(a) ESF Enfermeiro(a) ESF*
*Somente deverá encaminhar se a paciente já possuir os exames complementares obrigatórios realizados e com resultados disponíveis, registrando o resultado no encaminhamento. Na ausência dos exames obrigatórios, a paciente deve ser encaminhada para consulta médica na APS, a fim de avaliação e solicitação dos exames necessários. ** Obrigatório encaminhar com resultado de exame de imagem. *** A remoção do DIU pode ser realizada pelo médico(a) ESF e, somente caso não seja possível a retirada na ESF, pode ser encaminhado pelo médico(a) com a devida justificativa.	

Obrigatório conter no encaminhamento:

- Descrição da história clínica completa incluindo:
 - Sintomatologia,
 - Exame físico ginecológico,
 - História familiar,
 - História ginecológica e obstétrica,

- Comorbidades,
- Tratamentos farmacológicos (com dose e posologia) ou não-farmacológicos em uso;
- Descrição do resultado com data dos exames complementares obrigatórios;
- Outras informações relevantes.

Importante:

O tratamento das lesões condilomatosas pode ser realizado no âmbito da ESF com ácido tricloroacético a 80-90%, em solução alcoólica, se disponível na UBSF. Se lesão única ou poucas lesões, especialmente se assintomáticas, considerar apenas observar a evolução

REFERÊNCIAS

SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Saúde. Superintendência de Serviços Especializados e Regulação. Gerência de Regulação Ambulatorial. **Protocolo de Acesso: Consulta em Ginecologia**. Atualização: jun. 2023. Florianópolis: Secretaria de Estado da Saúde, 2023. Disponível em: <https://www.saude.sc.gov.br/index.php/pt/regulacao/protocolo-de-acesso-e-classificacao-de-risco/ginecologia-e-obstetricia/download>. Acesso em: 20 out. 2025.

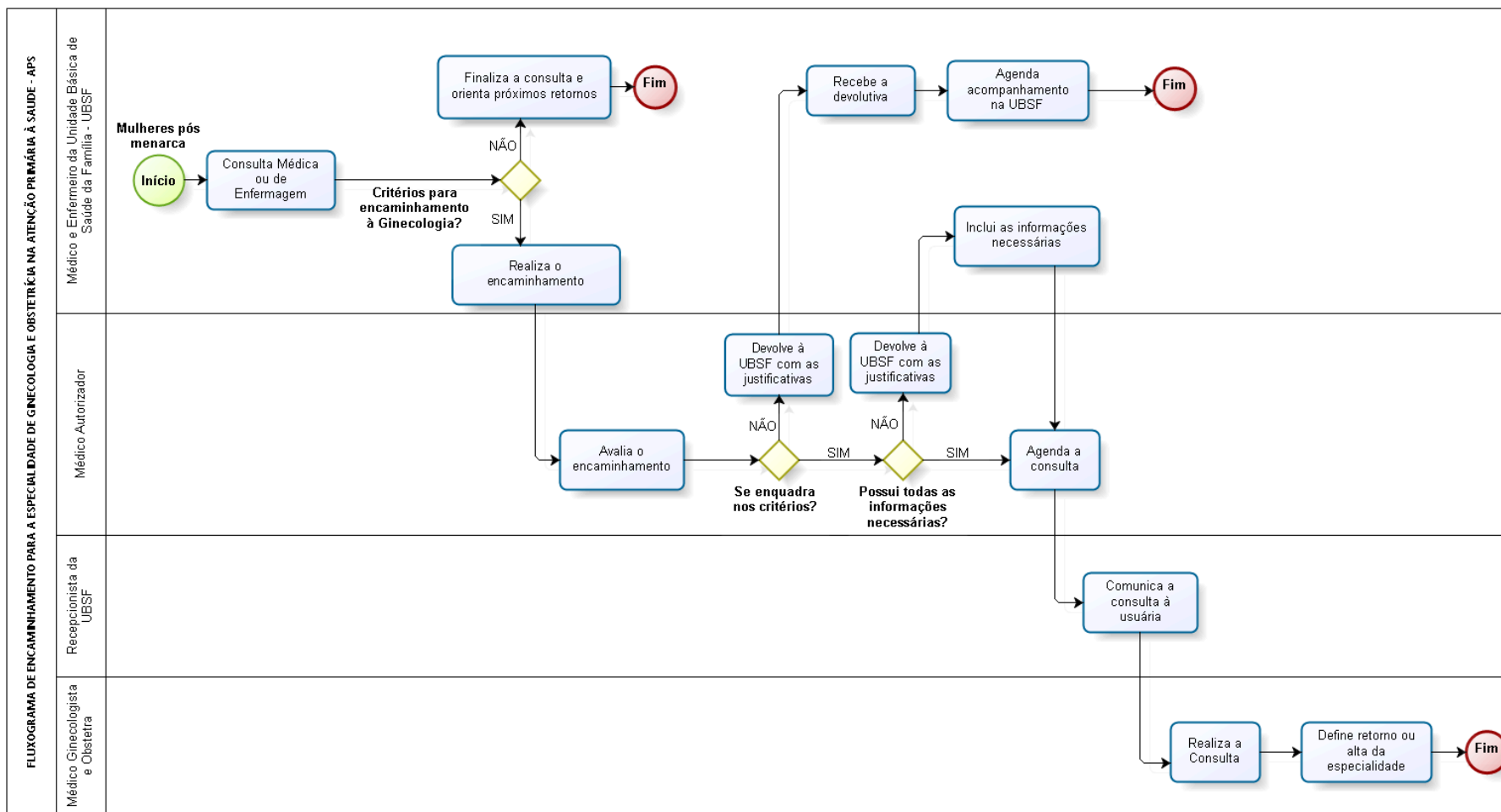
BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolos de Encaminhamento da Atenção Básica para a Atenção Especializada: Ginecologia**. Brasília: Ministério da Saúde, 2016. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolos_atencao_basica_especializada_ginecologia_v_IV.pdf. Acesso em: 20 out. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/aids/pt-br/centrais-de-conteudo/pcdts/2022/ist/pcdt-ist-2022_isbn-1.pdf/view. Acesso em: 20 out. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolos da Atenção Básica: saúde das mulheres. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2016. 230 p. ISBN 978-85-334-2360-2

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca. **PACK Brasil Adulto: Practical Approach to Care Kit: Kit de Cuidados em Atenção Primária: ferramenta de manejo clínico em Atenção Primária à Saúde**. Rio de Janeiro: Fiocruz, ENSP, Fiotec, Knowledge Translation Unit, University of Cape Town, 2025. 189 p. ISBN 9786589501824.

Anexo A. Fluxograma de encaminhamento para a especialidade de ginecologia e obstetrícia na Atenção Primária à Saúde - APS



Elaborado: NGQ, 2026.